

9. 기분 변화

- 중요성(rationale)
 - 1. 다른 질환과의 감별
 - 2. 약물 치료와 정신치료를 지속

평가 목표

원인		
정상 범위의 기분 변화	애도반응, 정상적 슬픔	
우울증	주요우울장애, 지속성 우울장애, 월경 전 불쾌감 장애, 파괴적 기분조절부전 장애	
조증과 우울증이 반복	제 1 형 양극성 장애: 확실한 조증(Mania) 삽화가 있음. 제 2 형 양극성 장애: 경조증(Hypomania) + 주요우울 삽화가 반복됨. 순환성 장애 (Cyclothymic): 경미한 조증과 우울이 2 년 이상 반복됨.	
다른 정신질환에 동반된 기분 변화	적응장애, 조현정동장애, 조현병, 인격장애	
시점, 물질사용, 신체질환 등으로 유도된 기분 변화	신체 질환에 의한 기분장애: 내분비 (갑상샘 저하증/항진증, 쿠싱 증후군) 뇌질환 (파킨슨병, 뇌졸중, 치매, 뇌종양) 물질/약물 유발 기분장애: 약물 부작용 (스테로이드, 항고혈압제, 경구피임약), 물질 남용 (알코올, 마약류 중독 및 금단) 특수 시점 유발: 산후 우울증/산후 정신병(출산 후 4 주 이내), 계절성 양상	
평가목표		
1) 일시적이지 기분 변화와 우울삽화 및 조증삽화를 구별 2) 기분장애와 다른 정신질환을 감별, 진단 및 치료 계획 수립		
구체적인 성과		
병력 청취	정상적인 기분 변화와 병적인 기분장애	기간: 우울(2 주 이상), 조증(1 주 이상) 지속 여부 기능 저하: 직업적, 사회적, 가사 활동의 뚜렷한 손상 기분 반응성: 즐거운 상황에서 일시적인 기분 호전 여부 (정상/비정형 우울) 주관적 고통: 본인이 느끼는 고통의 깊이와 통제 가능성
	우울증의 기본증상(흥미상실 등)	기분: 하루 종일 지속되는 우울감 Sleep : 불면(입면/숙면 장애) 또는 과다 수면 Interest : 즐거움/흥미상실 Guilt : 무가치감, 과도하거나 부적절한 죄책감 Energy : 피로감, 활력 상실 Concentration : 사고력 및 집중력 저하, 우유부단함 Appetite : 식욕 부진 또는 폭식, 체중 변화 Psychomotor : 정신운동 지체 또는 초조 Suicidality : 반복적인 죽음 생각 및 자살 사고
	조증의 기본증상(기분고양 등)	기분: 고양감(Euphoria), 과대함 또는 과민한 기분(Irritability) Distractibility : 사소한 외부 자극에 의한 주의 산만 Indiscretion : 무분별한 쇼핑, 성적 일탈, 어리석은 투자 등 충동적 행동 Grandiosity : 자신감 과잉, 자존감 팽창(특수 능력/지위 등) Flight of ideas : 사고의 비약, 생각이 질주하는 듯한 느낌 Activity : 목표 지향적 활동 증가(일, 사회적 활동, 성관계 등) Sleep : 수면 욕구 감소(적게 자도 에너지가 넘침) Talkativeness : 평소보다 말이 많아짐, 중단시키기 어려울 정도의 압박뇨
	기분 변화의 유발요인이나 악화요인	스트레스: 최근 사별, 이별, 실직, 경제적 파탄 등 심리적 외상 계절성: 특정 계절에 따른 반복적 발병 양상 주기성: 월경 전 기분 변화(PMDD) 또는 출산 후 발병 여부

	다른 정신질환이나 물질사용장애 또는 신체질환에 의한 기분변화	정신질환: 환청, 망상(피해/관계망상) 등 정신병적 증상 동반 여부 신체질환: 갑상샘 기능(저하/항진), 파킨슨병, 뇌졸중, 체장암 등 기질적 질환 물질/약물: 알코올, 마약류(코카인 등), 스테로이드, 항고혈압제, 경구 피임약 성격 구조: 만성적인 대인관계 불안정성 및 기분 기복(인격장애 가능성)
	자살사고와 자살시도	자살 사고: 죽고 싶다는 생각의 빈도와 강도 자살 계획: 구체적인 방법(약물, 투신 등) 구상 여부 자살 의도: 실제로 실행에 옮기려는 의지 치명적 수단: 번개탄, 약물, 흉기 등 수단 확보 여부 자살 시도력: 과거의 실제 시도 경험 (가장 강력한 예측 인자)
신체진찰	정신상태 평가	외모: 복장 상태, 위생 수준, 실제 연령과의 일치 여부 태도 및 행동: 눈맞춤(접촉 회피/강렬함), 안절부절못함(초조), 행동 느려짐(지체) 언어: 말의 속도, 음량, 말투의 일관성 정동 및 기분: 주관적 기분, 객관적 표정의 범위와 적절성 사고 과정: 사고의 비약(조증), 사고의 지연(우울), 논리적 일관성 사고 내용: 자살 사고, 망상(과대/피해/허무망상) 지각: 환각(환청, 환시 등) 유무 인지: 지남력(시간/장소/사람), 주의집중력, 기억력 병식 및 판단력: 자신의 병에 대한 인식, 사회적 상황 판단 능력
	물질사용이나 신체진환에 의한 기분변화를 감별	활력 징후: 빈맥/서맥, 혈압, 체온(항진/저하증 또는 약물 중독/금단 확인) 결막 및 공막: 빈혈, 황달(알코올성 간질환), 동공 크기(마약류/약물 반응) 갑상샘: 갑상샘 비대 및 압통 여부 촉진 심폐진찰: 심계항진, 호흡음 이상 여부 피부: 주사 자국(마약류), 피부 건조도(저하증), 식은땀(항진증/금단) 손: 손발 떨림(항진증/금단/리튬 부작용), 손톱 모양 신경학적 검사: 근력 저하, 반사(DTR) 이상, 보행 이상(파킨슨병, 뇌졸중 징후)
진단 및 치료	기분변화를 확인할 수 있는 평가척도(심리검사) 의뢰	우울 증상 평가: BDI(Beck Depression Inventory) , PHQ-9(Patient Health Questionnaire) 조증 증상 평가: MDQ(Mood Disorder Questionnaire), YMRS(Young Mania Rating Scale) 전반적 심리 상태: MMPI(다면적 인성 검사) , SCT(문장 완성 검사) 인지 기능 평가: MMSE(간이정신상태검사) , SNSB(서울신경심리검사)
	물질사용이나 신체질환에 의한 기분변화의 감별	기초 혈액 검사: CBC(빈혈), Electrolyte(전해질 불균형), TFT(갑상샘 기능 검사), 혈당, Cortisol, LFT(간 기능 - 알코올), RFT(신장 기능- 약물 처방 전 기저 상태 확인) 약물/물질 검사: Urine Drug Screen(마약류), 혈중 알코올 농도 뇌 영상 검사: Brain CT/MRI (신경학적 징후나 고령에서의 갑작스러운 발병 시)
	환자를 안심시키고 격려	비난 금지: 기분 변화가 의지의 문제가 아닌 치료가 필요한 질환임을 명시 공감과 수용: 환자의 고통을 인정하고 경청하는 자세 유지 희망 부여: 적절한 치료를 통해 충분히 호전될 수 있음을 강조
	원인에 따른 치료계획을 수립	주요우울장애: 항우울제 및 인지행동치료 양극성 장애: 기분조절제(Lithium, Valproate 등) 중심의 약물 요법 신체 질환 유발: 원인 질환(예: 갑상샘 저하증) 우선 치료 물질 유발: 해당 물질 중단 및 금단 증상 관리
	급성기의 증상완화를 위한 약물치료와 정신치료계획	약물 치료: 우울기: SSRI(항우울제), 필요시 소량의 항정신병 약물 병용 조증기: 기분조절제, 급성 초조 시 정맥/근육 주사 또는 Benzodiazepine 위기 관리(자살 위험 시): 폐쇄병동 입원 고려, 24 시간 감시
환자 교육	우울증 치료의 개요	질환의 성격: 의지 부족이나 성격 탓이 아닌, 뇌의 신경전달물질(세로토닌 등) 불균형에 의한 생물학적 질환임을 강조 약물 치료: 항우울제 복용의 필요성, 효과 발현까지의 시간(최소 2~4 주 이상) 설명

		증상이 좋아져도 재발 방지를 위해 유지 복용(약 6~9 개월)이 필수적임을 안내 정신사회적 치료: 인지행동치료를 통해 부정적인 사고 패턴을 교정할 수 있음을 설명 생활 습관: 규칙적인 운동과 충분한 일조량 확보 권고, 술은 우울감을 악화시키고 약물 효과를 방해하므로 금주 지시 가족 협조: 환자를 비난하거나 보채지 말고 묵묵히 지지해줄 것을 당부
	조증 치료의 개요	질환의 성격: 기분이 극단적으로 변하는 만성적인 뇌 질환임을 설명 약물 치료: 기분 조절제가 치료의 핵심임을 인지시킴, 약물을 임의로 중단할 경우 재발 위험이 매우 높음을 경고 입원 치료: 자신이나 타인에게 해를 끼칠 위험이 있거나, 판단력이 심하게 저하된 경우 안전을 위해 폐쇄병동 입원이 필요할 수 있음을 안내 환경 및 리듬 관리: 규칙적인 수면-각성 주기 유지가 재발 방지에 중요함을 강조 카페인, 알코올 등 중추신경에 영향을 주는 물질 섭취 제한 조기 징후 교육: 잠이 줄거나 말이 빨라지는 등 재발의 전조 증상이 보일 때 즉시 내원하도록 교육

● 원인 질환 정리

질환		병력 청취	검사	치료
원발성	주요우울장애 5+1	다음 중 5 가지 이상의 증상이 2 주 연속 지속 우울 - 의욕 저하 - 식욕 부진 - 수면장애 - 피로 - 죄책감 - 사고력장애 - 정신 운동 초조 - 자살 사고	TFT, LFT, BDI, ECG	항우울제, 전기경련요법, 인지행동치료
	산후 우울증 2	주요우울장애의 특정형 중 하나. 기분 증상이 임신 기간이나 분만 후 4 주 이내 발생. 정신병적 증상 자주 동반.	TFT, LFT, BDI, ECG	항우울제, 전기경련요법, 인지행동치료
	양극성 장애 1 형	최소 1 번의 조증삽화가 존재 조증삽화: 1 주 + DIG FAST 중 3 가지 이상 + 사회적기능 손상, 정신병적	TFT, LFT, ECG, BUN/Cr, BDI	기분안정제(리튬, 항경련제), 전기경련요법, 인지행동치료
	양극성 장애 2 형 2+1	최소 1 번의 경조증삽화와 한 번의 주요우울삽화가 존재 경조증삽화: 4 일 + DIG FAST 중 3 가지 이상 + 사회적 기능 손상 X	TFT, LFT, ECG, BUN/Cr, BDI	기분안정제(리튬, 항경련제), 전기경련요법, 인지행동치료
	순환기분 장애 1	2 년 이상 주요 우울장애 기준에 미치지 못하는 우울 증상과 경조증삽화의 진단기준을 만족하지 않는 경조증 증상의 반복 (소아는 1 년)	TFT, LFT, BDI, ECG	기분조절제 (리튬, valproate 등)
	지속성 우울장애 0+1	심하지 않은 우울 정도가 2 년 이상 지속	TFT, LFT, BDI, ECG	MDD 와 유사
	월경전 불쾌장애 1+1	월경 전 주에 발생, 월경 주에 호전, 월경 다음주에 최소화되는 증상, 대부분의 월경주기마다 있음 불안정/과민성/우울/불안/흥미저하/집중력저하/피로/식욕변화 등 월경전증후군: 월경주기와 관련된 다양한 증상	TFT, BDI, 호르몬검사, 골반초음파	항우울제, 월경통 경감
	조현병	망상, 환각, 와해된 언어, 와해된 행동, 음성증상 중 2 개 이상, 최소 6 개월 지속, 6 개월 미만이면 조현양상장애, 1 개월 미만이면 단기정신병적 장애	TFT, LFT, BDI, ECG	항정신병약물, 전기경련요법, 정신사회적 치료
	적응장애	3 개월 이내 누구나 겪을 수 있는 스트레스에 반응	TFT, LFT, BDI, ECG	항우울제, BZD, 인지행동치료
	정상 애도반응	가까운 사람의 죽음 이후, 일상생활 기능손상 없음 경도의 죄책감, 환각, 죽음에 대한 생각은 가능	TFT, LFT, BDI, ECG	-
속발성	갑상샘 저하증	추위불내성, 의욕 저하, 체중 증가, 촉진 시 갑상샘 비대	TFT, LFT, BDI, ECG	Levothyroxine
	약물 유발	알코올/스테로이드/ 항정신병약	약물중단 후 확인	약물 중단 또는 변경
	뇌졸중	여러 마비 소견 및 국소 신경학적 이상 소견	뇌 CT/MRI, 혈관조영술	혈전용해제, 재활 치료

O	언제부터, 갑자기/서서히, 어떤 상황	
L	-	
D	계속/변화, 지속 시간, 빈도	
Co	심해지는지	
Ex	이전에도-> 특별한 사건? 치료?	
C	병전 성격 (Character) 정도: 얼마나 심각한지, 일상생활에 지장	
A	[주요우울장애] 우흥죄수체집피자 SIGECAPS sleep/interest/guilt/energy/concentration/appetite/psychomotor/suicide 하루종일 우울한 기분, 즐거움/흥미상실, 체중변화/식욕변화, 불면/과다수면, 정신운동초조/지연, 피로/활력상실, 무가치감/죄책감, 사고력/집중력감소, 자살사고 [양극성장애] 기분 (기분이 들떠서 무엇이든 할 수 있을 것 같음) 수면 (잠을 안자도 피곤하지 않음) 충동 (충동적으로 일을 벌임) [조현병] 망상 (누군가 자신에게 해를 끼치려 함) 환각 (남들에게 보이지 않는 것이 보이거나, 들리지 않는 것이 들림) [기질적] OPEN Q 갑상샘 (추위불내성, 체중 변화) 뇌졸중 (두통, 팔다리 힘빠짐)	
F	계절 (계절에 따른 변동) -r/o 순환성 출산 (최근 출산, 출산 후 우울) -r/o 산후우울증 적응 (6 개월 이내 특별한 사건) -r/o 적응장애	
E	건강검진	
외	수술, 외상	
과	HTN/DM/암/정신과	
약	복용중인 약 스테로이드 물질 오남용	
사	음주/흡연/직업/스트레스/식습관/운동	
가	가족관계 정신과 진료	
여	규칙적? 기분 변화가 월경/폐경과 연관? [PMDD] 월경전 심함, 시작하거나 끝나면 호전 갑작스러운 기분변화 / 대인관계 갈등 / 유방통, 관절통, 근육통 / 기타 우울증 증상	
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수, 출혈 3 목: 갑상샘 촉진 4 피부: 하지 오목부종, 자살시도 흔적? 5 심음 청진, 호흡음 청진
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기	
진단 계획	1 백 우울 척도 검사 2 혈액검사(TFT, LFT) 3 심전도 4 뇌 CT/MRI	
치료	자해 및 자살 위험, 타해 및 폭력 위험, 급성 정신병적 상태, 일상생활 불능 시 입원 권유! 1. 우울관련- 항우울제, 인지행동치료, 전기경련요법 2. 양극성장애, 순환기분장애- 리튬, 항경련제, 항정신병제, 인지행동치료	

교육	생활습관 교정 (안심/응급/회피교정)
	[안심] 정확한 원인을 파악해 관리하면 조절 가능하니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 또한, 환자분의 탓이 아닙니다. 의지력이 약해서 생긴 문제가 아니라, 뇌 안의 신경전달물질의 균형이 잠시 깨진 것입니다. 고혈압이나 당뇨처럼 치료가 필요한 질환입니다.
	[응급] 혹시나 기분이 너무 가라앉아 위험한 생각이 든다면, 즉시 병원으로 연락하시거나 24 시간 자살 예방 상담 전화(109)로 연락하셔야 합니다. 보호자분께서는 환자의 말을 비난 없이 들어 주시고, 환자가 위험한 물건에 접근하지 않도록 도와주세요.
	[입원선택] 환자분, 지금 하시는 말씀이나 생각들을 종합해 볼 때, 스스로를 조절하기가 매우 힘든 위험한 단계에 와 계신 것 같습니다. 현재 외래 진료만으로는 증상 조절에 한계가 있어 보입니다. 입원을 하시면 매일 상태 변화를 세밀하게 관찰하며 약물을 신속하게 조정할 수 있어, 치료 기간을 오히려 단축할 수 있습니다. 또한, 갈등이 있는 가족 관계, 직장 스트레스, 술이나 도박 같은 유혹 환경으로부터 물리적으로 격리되어 오로지 자신의 회복에만 집중할 수 있는 최적의 환경이 될 수 있습니다. 주치의 뿐만 아니라 여러 의료진이 팀을 이루어서 환자분의 회복과 일상으로의 복귀를 돕겠습니다.
	[항우울제] 항우울제는 감기약처럼 바로 효과가 나타나지 않습니다. 보통 2~4 주 정도 꾸준히 복용 해야 기분이 개선되기 시작하니 조금해하지 마세요. 증상이 조금 좋아졌다고 바로 끊으면 재발 위험이 큼니다. 최소 6 개월 이상 지속적으로 약물을 복용하시는 것이 중요하며, 반드시 주치의와 상의해서 용량을 조절해야 합니다. 초기에 입 마름이나 약간의 속 쓰림이 있을 수 있지만, 대개 시간이 지나면 적응됩니다.
PPI	[인지행동치료] 기분이 우울해지면 자신도 모르게 부정적인 생각들이 떠오르곤 하죠? 이런 생각들이 환자분을 더 우울하게 만듭니다. 인지행동치료는 이런 잘못된 생각의 습관을 찾아서 좀 더 건강하고 합리적인 생각으로 바꾸는 연습이에요. 마치 마음의 근육을 단련하는 훈련과 같아서, 꾸준히 연습하시면 나중에 약 없이도 스트레스를 이겨낼 힘이 생기실 거예요.
	[회피/교정] 운동/식사/수면/금주/스트레스 정해진 시간에 자고 일어나며, 낮잠은 피하는 것이 좋습니다. 술은 우울 증상을 악화시키고 약물 효과를 방해하므로 피해야 합니다. 거창한 운동보다는 하루 15 분 햇볕을 쬐며 산책하는 것부터 시작해 보세요. 우울한 기분을 낮게 해줄 수 있는 수영, 요가 등의 운동을 해보시는 것도 좋습니다. 스트레스가 쌓이면 부정적인 생각에 사로잡히지 않도록 긍정적인 생각을 자주하고, 건강한 스트레스 해소 방법을 찾도록 노력하는 것이 필요합니다. 우울한 상태에서는 판단력이 흐려질 수 있으므로 이직, 이혼, 이사 등 중요한 결정은 회복된 후로 미루는 것이 좋습니다.
PPI	궁금하신 점 있으실까요?

[선택이 도저히 안될 때]- 낮 병동

완전히 입원하는 것은 답답하고 세상과 단절되는 느낌이 들어 거부감이 크실 수 있습니다. 낮 병동은 아침에 출근하듯 병원에 오셔서 치료받고, 저녁에는 댁으로 돌아가 가족과 함께 시간을 보낼 수 있는 가장 자유로운 형태의 집중 치료입니다. 집에 혼자 계시면 자칫 무기력해지거나 부정적인 생각에 빠지기 쉽습니다. 낮 병동에서는 전문가들이 설계한 인지행동치료, 사회기술훈련 등 다양한 프로그램에 참여하시게 되므로, 외래 진료만 받을 때보다 회복 속도가 눈에 띄게 빨라집니다. 어떠신가요?